

ANEXO 1

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE HISTORIA CLÍNICA DE LA NIÑA Y EL NIÑO

La historia clínica estandarizada es un instrumento normado para la atención de la niña y el niño. Es un documento técnico y legal auditable, por lo tanto, su elaboración es de responsabilidad profesional y ética.

Objetivo de la historia clínica en la atención integral

- Recoger los datos importantes de la niña y el niño, desde los antecedentes familiares, prenatales, natales y posnatales que permitan organizar la atención brindada.

Historia clínica de atención integral de la niña y del niño

La elaboración de historia clínica de la niña y el niño incluye:

- Plan de atención.
- Datos de filiación y antecedentes.
- Evaluación de la alimentación.
- Formato de consulta.
- Ficha de tamizaje de violencia y maltrato infantil.
- Curvas de Evaluación del Crecimiento (niñas, niños).
- Curvas de Perímetro Cefálico.

1era. Cara: Plan de atención integral

La elaboración del plan de atención consiste en la organización de datos relacionados a la niña o niño, para lo cual el prestador de salud utiliza estrategias e instrumentos como la entrevista, la observación, el examen clínico, anamnesis, entre otros, a fin de obtener la información adecuada que le permita determinar los riesgos, problemas y necesidades de salud. Esta información es la base para las decisiones y actuaciones posteriores.

- En la primera parte se debe consignar muy claramente datos de identificación de la niña o niño.
- En la segunda parte, problemas y necesidades de salud, hay que consignar información relevante sobre factores de riesgo para crecimiento y desarrollo, situación de la salud de la niña y el niño u otro dato que se considere destacada facilitando así la priorización de la atención.
- En la tercera parte se encuentra el listado de las prestaciones integrales de la salud de la niña y el niño que deben ejecutarse para el logar los objetivos.
- Para el registro de fechas de las actividades realizadas, se sugiere usar lápiz para lo programado y lapicero para lo ejecutado.

2da. Cara: Datos de filiación

- Primera parte: consignar el establecimiento de salud donde se atiende, N° de HC, Código de afiliación SIS.
- Segunda parte: datos generales, apellidos y nombres del niño o niña, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio referencia, DNI, grupo sanguíneo, factor RH. Nombres y apellidos de la madre o padre tutor, edad, DNI, teléfono, ocupación, estado civil, religión.
- Tercera parte: antecedentes
 - Antecedentes personales:
 - Antecedentes perinatales
 - Embarazo, parto (contacto piel a piel, lactancia materna precoz), nacimiento, después del nacimiento.
 - Antecedentes patológicos.
 - Antecedentes familiares.
 - Factores de riesgo social.



- Cuarta Parte
 - Esquema de vacunación
- Quinta parte
 - Tamizaje

3ra. Cara: Evaluación de la alimentación

- Primera parte:

Cuadro de evaluación de la alimentación de la niña y niño menor de 36 meses.

Debe consignar información mensual, preguntando a la madre y evaluando a través de la observación.

- Segunda parte
 - Evaluación de la alimentación complementaria de la niña y el niño menor de 36 meses.
 - Los cuadros deben ser completados a través de la entrevista a la madre, padre o cuidador. Leer las instrucciones debajo de cada cuadro antes de registrar la respuesta.
 - Evaluación de la alimentación complementaria de la niña y el niño de 9 a 11 meses.
 - Los cuadros deben ser completados a través de la entrevista a la madre, padre o cuidador. Leer las instrucciones debajo de cada cuadro antes de registrar la respuesta.
 - Evaluación de la alimentación complementaria de la niña y el niño a partir del 1er año.
 - Los cuadros deben ser completados a través de la entrevista a la madre, padre o cuidador. Leer las instrucciones debajo de cada cuadro antes de registrar la respuesta.

4ta. Cara: Formato de Consulta

Considera:

- Signos de peligro clasificado por edades, según AIEPI.
- Anamnesis.
- Motivo de consulta.
- Examen físico.
- Diagnóstico.
- Condición del crecimiento.
- Diagnóstico del desarrollo.
- Tratamiento.
- Exámenes auxiliares.
- Compromisos.
- Observaciones.

5ta. Cara: Ficha de Tamizaje de violencia y maltrato infantil

La detección del maltrato y violencia infantil se realiza en cada control del crecimiento y desarrollo a través de oferta fija (establecimientos de salud, otros escenarios de la comunidad) y oferta móvil (brigadas o equipos itinerantes). Se deberá aplicar la "Ficha de tamizaje de maltrato infantil y violencia familiar".

Se inicia con la búsqueda de factores de riesgo y factores protectores en la apertura de la historia clínica, recabando información sobre aspectos psicosociales, dinámica familiar, entre otros. Esta información debe ser actualizada en los controles sucesivos evaluando la calidad del vínculo afectivo entre padres e hijos, cuidados que se proveen a niñas o niños, presencia de síntomas que sugieren abandono, trato negligente, carencia afectiva, actitud de los padres frente al establecimiento sobre normas y límites (castigo físico, correcciones verbales desproporcionadas, entre otros).

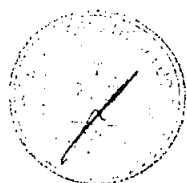


6ta. y 7ma. Cara: Curvas de evaluación nutricional de las niñas y niños

Los nuevos patrones de crecimiento infantil de la OMS proporcionan información sobre el crecimiento idóneo de las niñas y niños. El crecimiento normal es una expresión fundamental de la buena salud y una medida de los esfuerzos realizados para reducir la mortalidad y morbilidad en la niñez. Los nuevos gráficos constituyen, por consiguiente, un instrumento sencillo para evaluar la eficacia de estos esfuerzos.

8va. Cara: Curvas de Perímetro cefálico

La medición del Perímetro Cefálico (PC), en la infancia, predice certeramente el volumen cerebral. Por tanto, mediante el PC se considera el crecimiento del cráneo y de sus estructuras internas y, en un sentido amplio, la medición del PC constituye el medio más sencillo y disponible que contribuye a evaluar el desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC). Además, también constituye el parámetro de crecimiento más importante para predecir el neurodesarrollo ulterior de la niña y niño.



ANEXO N° 1 FORMATO DE HISTORIA CLINICA PLAN DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD											
N° de Historia Clínica			Ción SIS u otro Seguro :			CUIDNI					
Apellidos						F. de Nac.					
Nombres						Sexo:		M F			
Problemas y Necesidades											
PLAN DE ATENCION INTEGRAL			CODIGO HIS	GRUPOS DE EDADES							
				0 - 25d		1m - 11m		1 año	2 años	3 años	4 años
N°	PRESTACION DE SALUD	DESCRIPCION		FECHA		FECHA		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Valoración 1ra Consulta : Antecedentes - Tamizaje - Identificación de factores de riesgo.	C8002 Dx = D, Lab= 1)								
2	ATENCION DEL RECIENT NACIDO	Considerar si el niño ha sido atendido en EE.SS. del Nivel y Hospitales	Dx = D								
3	TAMIZAJE METABOLICO NEONATAL	Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística.	80099 Muestra / 2138 Resultados								
4	TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL	Descarte de sordera en etapa neonatal									
5	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	A partir del 1° mes	Z001 Dx=D, Lab=1,2,...								
4	INMUNIZACIONES	A partir del nacimiento									
5	TAMIZAJE DE ANEMIA (Examen de Laboratorio)	A partir de los 4 meses	ZD17, Dx =P								
6	DESCARTE DE PARASITOSIS	A partir del año	Z 119, Dx = P								
7	TAMIZAJE DE SALUD MENTAL	Detectar Riesgo de Violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil.	U140, Dx = D, Lab: VIF								
8	ORIENTACION INTEGRAL	Lactancia Materna, Signos de Alarma y Cuidados del Recién Nacido.	99401 Dx = R, Lab: 1								
9	CONSEJERIA NUTRICIONAL	Según norma técnica y de acuerdo a la necesidad.	99403 Dx=D, Lab=1,2,...								
7	TRATAMIENTO	Anemia.	Z208								
		Parasitosis.	Z292								
9	ATENCION TEMPRANA	Potenciar habilidades en el niño y niña.	99411								
9	SESIONES DEMOSTRATIVAS	Actividad educativa en la que los participantes aprenden a combinar los alimentos en forma adecuada.	CD010								
10	ADMINISTRACION DE HIERRO (SULFATO FERROSO / MICRONUTRIENTES)	Hierro	Z 298, Dx = D, Lab: SF1, SF2, SF3, SF4, SF5								
		Vitamina A									
		Multimicronutrientes									
11	ATENCION ODONTOLOGICA	Atención Odontológica									
		Aplicación de barnices y/o Sellantes.									
		Fluorizaciones									
12	EVALUACION PSICOSOCIAL	Evaluación de las habilidades sociales y cognitivas, identifica problemas de aprendizaje y de conducta riesgo.	U140, Dx = D, Lab: OH								
13	EVALUACION AGUDEZA VISUAL	Se realiza la evaluación a partir de los 03 años	Z010, Dx = D								
VISITA FAMILIAR INTEGRAL - SEGUIMIENTO			Actividad extramural que se realiza el seguimiento y control del niño.	99344, Dx = D							





Ministerio de Salud

2

FORMATO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO

Estab. de Salud: _____

N° de Historia Clínica: _____

Cód. Afiliación SIS u otro Seguro: _____

DATOS GENERALES

Apellidos		Nombres		Sexo: M ☐ F ☐	Edad: _____
Lugar de Nacimiento: _____		Domicilio/Referencia: _____		CUI/DNI: _____	G.S. Rh: _____
Nombre y Apellidos de la Madre		Edad	Identificación (DNI)	Teléfono, Domicilio/Movil	
Grado de Instrucción	Ocupación	Estado civil		Religión	
Nombre y Apellidos del Padre		Edad	Identificación (DNI)	Teléfono, Domicilio/Movil	
Grado de Instrucción	Ocupación	Estado civil		Religión	

Antecedentes Personales:

1. Antecedentes Perinatales:

1.1 Embarazo: Normal ☐ Complicado ☐

Patología(s) durante la gestación:

- *Embarazo de riesgo ☐
- *Infecciones intrauterinas, vaginales, ITU ☐
- *Diabetes gestacional ☐
- *Hipertensión arterial ☐
- *Anemia ☐

Control Prenatal: Si ☐ No ☐

N° CPN ☐ N° de embarazo ☐

1.2 Parto: Parto Eutócico ☐ Complicado ☐

Complicaciones del parto: _____

Lugar del parto: _____

EESS ☐ Domicilio ☐

Atendido por: _____

Profesional de Salud ACS ☐ Técnico Familiar ☐

Otro (especificar): _____

Corte tardío del cordón umbilical: <3min ☐ 3min a + ☐

Contacto piel a piel: Si ☐ No ☐

Lactancia precoz: No ☐ 15m ☐ 30m ☐ 45m ☐

1.3 Nacimiento

Edad Gest. al nacer (sem): _____

A término (37 a 40) ☐

Pre término (<36) ☐

Peso al nacer (gr): _____

Talla al nacer (cm): _____

Perímetro cefálico: _____

Sufrimiento fetal: _____

2. Antec. Patológicos

	Si	No
TBC	☐	☐
SOBA / Asma	☐	☐
Transfusiones sang.	☐	☐
Neurológico	☐	☐
Alergia a medic.: _____	☐	☐
Otros:	☐	☐

Respiración y llanto al nacer: Fue inmediato Si ☐ No ☐

APGAR 1 min ☐ 5 min ☐

Reanimación Si ☐ No ☐

Patología Neonatal: Si ☐ No ☐

Especifique: _____

Hospitalización Si ☐ No ☐

Tiempo de hospitalización: _____

3. Antecedente familiares

Quién	Si	No
Tuberculosis	☐	☐
VIH-SIDA	☐	☐
Diabetes	☐	☐
Epilepsia	☐	☐
Alergia a medicinas	☐	☐
Violencia familiar	☐	☐
Alcoholismo	☐	☐
Drogadicción	☐	☐
Hepatitis	☐	☐
Padre(P), Madre(M), Hno(H), Abuelo(A)	☐	☐

4. Factores de riesgo social

Cuidador del niño(a): _____

Apoyo de familiares: Si ☐ No ☐

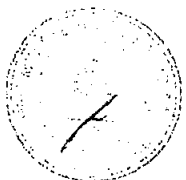
Embarazo adolescente: Si ☐ No ☐

Número de hijos: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ >3 ☐

Últimos embarazos espaciados: <2 ☐ 2 a 5 ☐ >5 ☐

	VACUNAS	DOSES	FECHA
RN	BCG	Única	
	HVB	Única	
< DE 1 AÑO	PENTAVALENTE (2 MESES, 4 MESES y 6 MESES)	1°	
		2°	
		3°	
	ANTIPOLIO 2M (IPV), 4M (IPV) y 6M (OPV)	1°	
		2°	
		3°	
1 AÑO	ROTAVIRUS (2 MESES, 4 MESES)	1°	
		2°	
	NEUMOCOCO (2 MESES, 4 MESES)	1°	
		2°	
	INFLUENZA (7 MESES Y 6 MESES)	1°	
		2°	
4 AÑOS	SPR (12 MESES)	1°	
	NEUMOCOCO (12 MESES)	3°	
	ANTIAMARILICA (15 MESES)	Única	
	1ER. REF. DPT (18 MESES)	1°R	
	1ER. REF. APO (18 MESES)	1°R	

EDAD	CONTROL CRED	EDAD	FECHA
RN	1°		
	2°		
	3°		
	4°		
< DE 1 AÑO	1°		
	2°		
	3°		
	4°		
	5°		
	6°		
	7°		
1 AÑO	1°		
	2°		
	3°		
	4°		
2 AÑOS	1°		
	2°		
3 AÑOS	1°		
	2°		



FECHA (escribir la fecha sobre la edad del niño/niña):

RN	RN	RN	RN	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	14m	16m	18m	20m	22m	24m	27m	30m
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

17. ¿Su niña o niño está

[illegible]

CONSULTA		
Fecha:	Hora:	Edad:

No present signs

Especifique:

Tiempo de enfermedad:	Forma de inicio:	Curso:
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------

3

Sobrepeso
Obesidad

4

Age Group	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	25	20	15	12	10
15-24	15	18	20	22	20
25-34	10	12	15	18	15
35-44	10	12	15	18	15
45-54	10	12	15	18	15
55-64	10	12	15	18	15
65-74	10	12	15	18	15
75+	10	12	15	18	15

Referencia (lugar y movimiento)	
---------------------------------	--

APELLIDOS Y NOMBRES

100

100

H.C.

H.C.



CONSULTA									
Fecha:		Hora:			Edad:				
Descarte de signos de peligro: (marcar los hallazgos) MENOR DE 2 MESES: No quiere mamar, ni succiona ☐ Convulsiones ☐ Fontanela abombada ☐ Enrojecimiento del ombligo se extiende a la piel ☐ Fiebre o temperatura baja ☐ Rigidez de la nuca ☐ Pústulas muchas y extensas ☐ Letárgico o comatoso ☐ DE 2 MESES A 4 AÑOS: No puede beber o tomar el pecho ☐ Convulsiones ☐ Letárgico o comatoso ☐ Vomita todo ☐ Estridor en reposo/tiraje subcostal ☐ PARA TODAS LAS EDADES: Emaciación visible grave ☐ Piel vuelve muy lentamente ☐ Traumatismo/Quemaduras ☐ Palidez palmar intensa ☐ No presenta signos ☐ IDENTIFIQUE FACTORES DE RIESGO ¿Quién cuida al niño? Participa el padre en el cuidado del niño? ☐ Si ☐ No El niño recibe muestras de afecto? ☐ Si ☐ No Especifique: _____									
ANAMNESIS									
1. Motivo de consulta: _____									
Tiempo de enfermedad:		Forma de inicio:			Curso:				
Examen físico	Signos vitales	T°	PA	FC	FR	Peso	Talla	PC	
Diagnóstico	A. Diagnóstico Nosológico o Síndrómico				2. Condición de crecimiento y estado nutricional			3. Diagnóstico del Desarrollo Psicomotor	
	1				Crecimiento adecuado			Riesgo para el desarrollo	
	2				Crecimiento inadecuado			Normal	
	3				Riesgo nutricional Ganancia inadecuada de peso o talla			Trastorno del desarrollo	
	B. Factores condicionantes de la salud, nutrición y desarrollo							Observaciones:	
1				Desnutrición					
2				Sobrepeso					
3				Obesidad					
Tratamiento					Acuerdos y compromisos negociados con la madre y/o cuidador del niño				
Exámenes Auxiliares					Referencia (lugar y motivo)				
Proxima cita:					Atendido por:				
Observación:					Firma y sello		Colegio profesional DNI		

CONSULTA									
Fecha:		Hora:			Edad:				
Descarte de signos de peligro: (marcar los hallazgos) MENOR DE 2 MESES: No quiere mamar, ni succiona ☐ Convulsiones ☐ Fontanela abombada ☐ Enrojecimiento del ombligo se extiende a la piel ☐ Fiebre o temperatura baja ☐ Rigidez de la nuca ☐ Pústulas muchas y extensas ☐ Letárgico o comatoso ☐ DE 2 MESES A 4 AÑOS: No puede beber o tomar el pecho ☐ Convulsiones ☐ Letárgico o comatoso ☐ Vomita todo ☐ Estridor en reposo/tiraje subcostal ☐ PARA TODAS LAS EDADES: Emaciación visible grave ☐ Piel vuelve muy lentamente ☐ Traumatismo/Quemaduras ☐ Palidez palmar intensa ☐ No presenta signos ☐ IDENTIFIQUE FACTORES DE RIESGO ¿Quién cuida al niño? Participa el padre en el cuidado del niño? ☐ Si ☐ No El niño recibe muestras de afecto? ☐ Si ☐ No Especifique: _____									
ANAMNESIS									
1. Motivo de consulta: _____									
Tiempo de enfermedad:		Forma de inicio:			Curso:				
Examen físico	Signos vitales	T°	PA	FC	FR	Peso	Talla	PC	
Diagnóstico	A. Diagnóstico Nosológico o Síndrómico				2. Condición de crecimiento y estado nutricional			3. Diagnóstico del Desarrollo Psicomotor	
	1				Crecimiento adecuado			Riesgo para el desarrollo	
	2				Crecimiento inadecuado			Normal	
	3				Riesgo nutricional Ganancia inadecuada de peso o talla			Trastorno del desarrollo	
	B. Factores condicionantes de la salud, nutrición y desarrollo							Observaciones:	
1				Desnutrición					
2				Sobrepeso					
3				Obesidad					
Tratamiento					Acuerdos y compromisos negociados con la madre y/o cuidador del niño				
Exámenes Auxiliares					Referencia (lugar y motivo)				
Proxima cita:					Atendido por:				
Observación:					Firma y sello		Colegio profesional DNI		

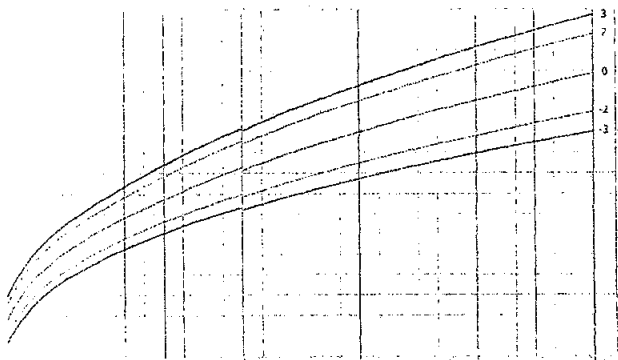
APELLIDOS Y NOMBRES

Nº DE HISTORIA CLINICA

GRAFICOS DE EVALUACION CRECIMIENTO < 5 AÑOS

Puntuación Z (Nacimiento a 5 años)

Organización
Mundial de la Salud

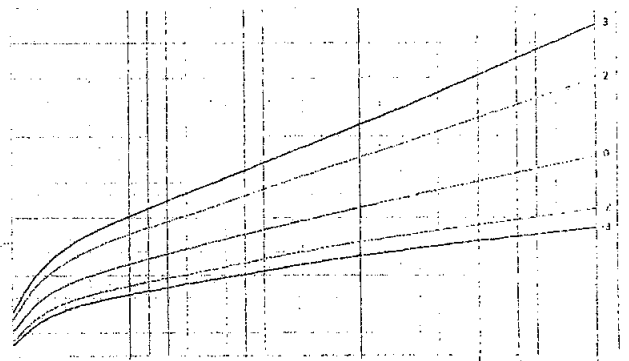


Patrones de crecimiento infantil de la OMS

GRAFICOS DE EVALUACION CRECIMIENTO < 5 AÑOS

Puntuación Z (Nacimiento a 5 años)

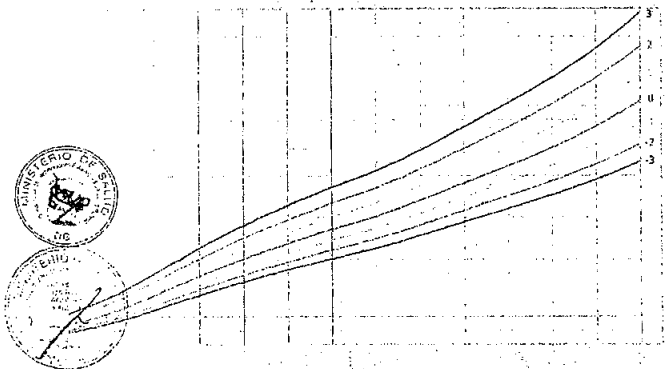
Organización
Mundial de la Salud



Patrones de crecimiento infantil de la OMS

Puntuación Z (Nacimiento a 2 años)

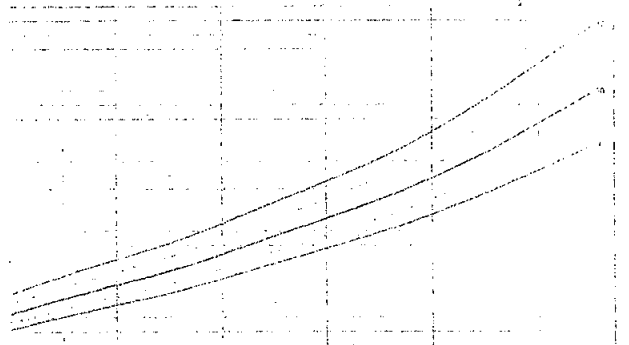
Organización
Mundial de la Salud



Patrones de crecimiento infantil de la OMS

Percentiles (2 a 5 años)

Organización
Mundial de la Salud



Patrones de crecimiento infantil de la OMS

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESP. DE LA ATENCION:

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESP. DE LA ATENCION:

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE:

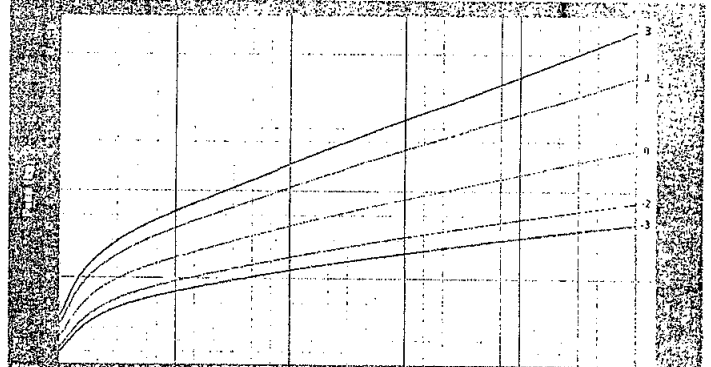
N°

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE:

N°

Peso para la edad Niños

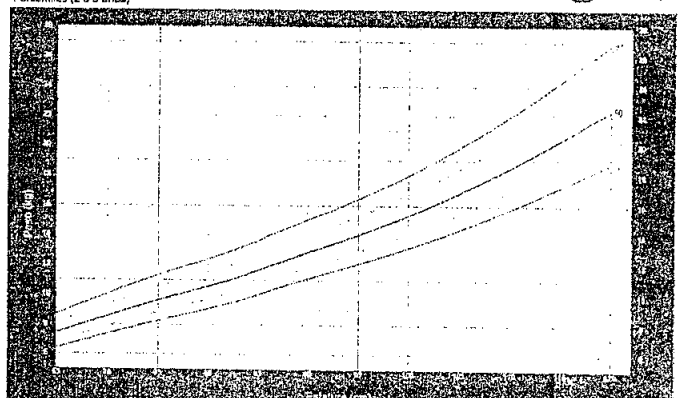
Puntuación Z (Nacimiento a 5 años)



Patronas de crecimiento infantil de la OMS

Peso para la estatura Niños

Percentiles (2 a 5 años)



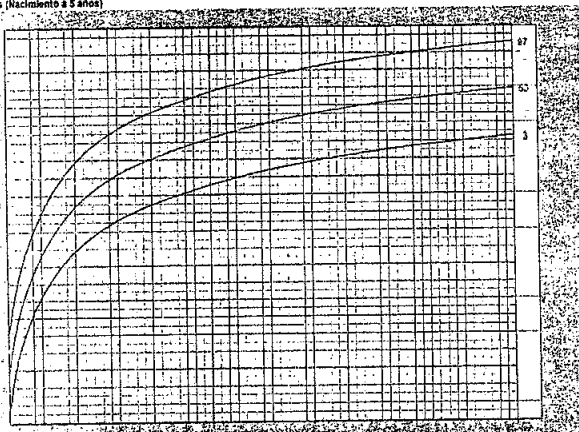
Patrones de crecimiento Infantil de la OMS

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESP. DE LA ATENCION:	
---	--

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE

Perímetro cefálico para la edad Niños
 Percentiles (Nacimiento a 5 años)

Organización
 Mundial de la Salud

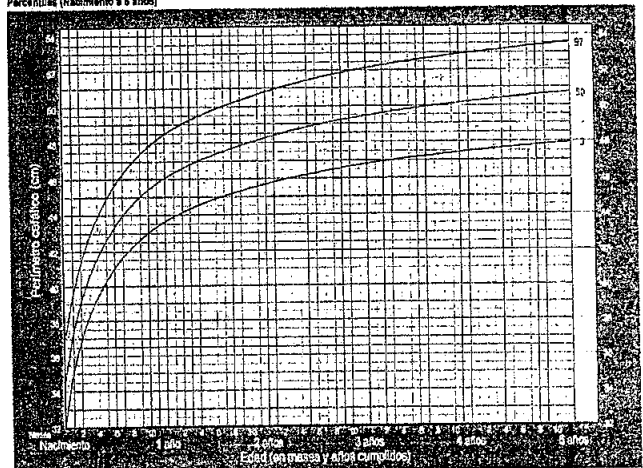


Patrones de crecimiento infantil de la OMS

Perímetro cefálico para la edad Niños

Organización
 Mundial de la Salud

Percentiles (Nacimiento a 5 años)



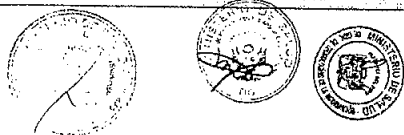
Patrones de crecimiento infantil de la OMS



ANEXO N° 2

CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y NIÑO MENOR DE 5 AÑOS

MONITOREO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA				Edad		Sexo		Estatus		Fecha		Lugar		Atención		Observaciones	
				Edad	Sexo	Estatus	Fecha	Lugar	Atención	Observaciones							
Datos de la Niña	Nombre de la Niña																
	Fecha de nacimiento																
	Fecha de ingreso																
	Fecha de egreso																
Datos de la Madre	Nombre de la Madre																
	Fecha de nacimiento																
	Fecha de ingreso																
	Fecha de egreso																
Datos de la Familia	Nombre de la Familia																
	Fecha de nacimiento																
	Fecha de ingreso																
	Fecha de egreso																
Datos de la Comunidad	Nombre de la Comunidad																
	Fecha de nacimiento																
	Fecha de ingreso																
	Fecha de egreso																



CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y NIÑO MENOR DE 5 AÑOS

FORMULARIO DE DATOS DEL NIÑO

Nombre: _____ Sexo: _____ Fecha de nacimiento: _____

Edad: _____ Meses: _____ Años: _____

Estado civil: _____ Ocupación: _____

Residencia: _____

Grupo sanguíneo: _____

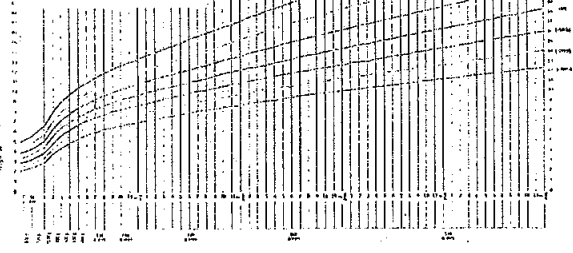
FORMULARIO DE DATOS DE LA MADRE

Nombre: _____ Edad: _____

Estado civil: _____ Ocupación: _____

Residencia: _____

Grupo sanguíneo: _____



FORMULARIO DE DATOS DEL NIÑO

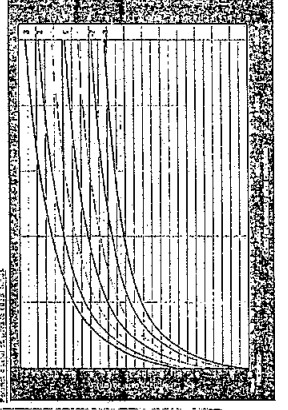
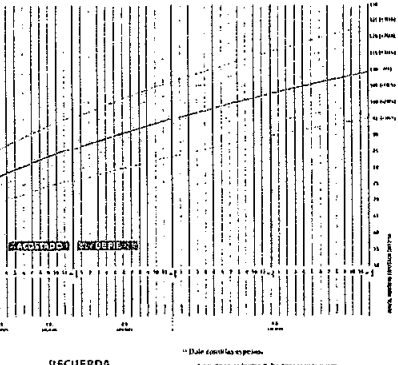
Nombre: _____ Sexo: _____ Fecha de nacimiento: _____

Edad: _____ Meses: _____ Años: _____

Estado civil: _____ Ocupación: _____

Residencia: _____

Grupo sanguíneo: _____



RECUERDA

1. Lavar siempre las manos con agua y jabón.

2. Antes y después de cambiar pañales.

3. Antes y después de preparar alimentos.

4. Antes y después de comer.

5. Antes y después de ir al baño.

6. Antes y después de ir al trabajo.

7. Antes y después de ir al colegio.

8. Antes y después de ir al supermercado.

9. Antes y después de ir al médico.

10. Antes y después de ir al dentista.

RECUERDA

1. Acariciar y besar a tu niño en todo momento.

2. Hablarle a tu niño en todo momento.

3. Cantarle canciones a tu niño en todo momento.

4. Leerle cuentos a tu niño en todo momento.

5. Jugar con tu niño en todo momento.

RECUERDA

1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

RECUERDA

1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

RECUERDA

1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

RECUERDA

1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

RECUERDA

1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

RECUERDA

1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

RECUERDA

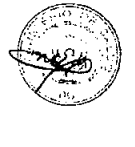
1. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

2. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

3. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

4. Darle leche materna a tu niño en todo momento.

5. Darle leche materna a tu niño en todo momento.



ANEXO N° 3

ASPECTOS PRÁCTICOS A CONSIDERAR EN EL CONTROL DEL CRED DE LA NIÑA Y EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS

El profesional de la salud que realiza el control del crecimiento y desarrollo a la niña y el niño deberá tener en cuenta el contexto cultural de las familias y las comunidades para asegurar que la atención sea de calidad y pertinencia, incluyendo el respeto de la diversidad cultural.

Esto supone que los aspectos prácticos detallados a continuación se adecúen a su realidad local.

1. Ambiente y Equipamiento

- El ambiente de la atención debe reunir las condiciones adecuadas de limpieza, comodidad, privacidad y seguridad para la niña, el niño y la madre, padre o cuidador que lo acompañe.
- Mantener una temperatura adecuada durante el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño según condiciones climáticas.
- El equipo y/o materiales a utilizar deben estar completos y en buen estado, cumpliendo con los estándares y especificaciones establecidos en esta norma.

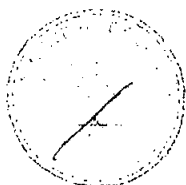
2.- Atención directa

Antes:

- Preparar los materiales y equipos que se utilizarán, así como los formatos, registros e instrumentos, de acuerdo a la edad de la niña y niño.
- Solicitar carné de atención integral de salud de la niña y niño menor de 5 años y revisión de la historia clínica para la identificación de antecedentes de la niña y el niño.
- Lavado de manos según norma de bioseguridad
- Retirar todos los accesorios de las manos para evitar accidentes en la atención.
- Considerar que la niña o niño esté despierto para realizar la evaluación CRED.

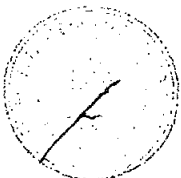
Durante:

- Saludar y presentarse cordialmente ante la madre, padre o cuidador, así como a la niña o niño manteniendo la empatía.
- El personal de la salud deberá respetar los valores, idioma y cultura del contexto familiar.
- Respetar la identidad e individualidad de la niña o niño, llamándolo por su nombre.
- Explicar a la madre, padre o cuidador de la niña y niño sobre los procedimientos que se van a realizar para obtener su colaboración.
- El personal de la salud deberá observar a la niña o niño en busca de algún signo de alarma y explorando a través de preguntas sencillas a la madre, padre o cuidador de la niña o niño, sobre aspectos relacionados con su integridad física y emocional.
- Recuerde anticipar a la niña o niño las acciones que se realizará, busque su mirada y evite en lo posible incomodarle, teniendo presente que es sujeto de derecho.
- Cuando la niña o niño lllore, anime a la madre, padre o cuidador que le acompaña, para calmarlo.



Después:

- Priorizar el diagnóstico para orientar las intervenciones oportunas.
- Informar a la madre, padre o cuidador sobre los resultados de la evaluación del crecimiento y desarrollo.
- Promover un espacio para la consejería sobre los aspectos observados en control del crecimiento y desarrollo.
- Promover que la madre, padre o cuidador asuman compromisos y acuerdos que surgen de la consejería.
- Al finalizar la atención se deberá registrar detalladamente todos los aspectos encontrados en el control del crecimiento y desarrollo de forma obligatoria y con letra legible en el carné de atención integral de salud de la niña y niño menor de 5 años, historia clínica, registros e instrumentos, por ser documentos relevantes para la atención del usuario, auditables y/o legales.
- Invitar a la madre, padre o cuidador a la próxima cita según edad y diagnóstico.



ANEXO N°4 REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL

FOLIO		PLAN AS		INMUNIZACIONES																											
HCL		Emb	Eje	BCG	HVS	PV	APO	PENTAVALENTE	NEUMOCOCCO	ROTAVIRUS	INFLUENZA	SPR	AMA	OPT	APO	OTROS															
CUDI				RN	RN	1°	2°	1°	1°	2°	3°	1°	2°	1°	2°	1° Ref	2° Ref	1° Ref	2° Ref												
COORDINADOR																															
NOMBRE Y APELLIDOS	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO																														
	RECEN NACIDO				MENOR DE 01 AÑO								01 AÑO				02 AÑOS														
FNAC	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	1°	2°	3°	4°						
MADRE	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO																														
PADRE	03 AÑOS				04 AÑOS				05 AÑOS				MENOR DE 01 AÑO				01 AÑO				02 AÑOS				03 AÑOS						
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°				
DIRECCION Y REFERENCIA	SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES																														
	GOTAS				MICRONUTRIENTES																ATENCION POR MORBILIDAD IRA, EDA, ANEMIA, PARASITOS, EMERGENCIA Y OTROS										
TIPO DE RIESGO	DESCARTE DE ENFERMEDADES PREVALENTES																														
	Tuberculosis				ANEMIA								Parasitos								ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES Y DE SEGUIMIENTO										
PROGRAMA SOCIAL	TSH	FC	FQ	HSR	Detección de hemoglobina								Examen Sero de Hechas																		
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°																	

FOLIO		PLAN AS		INMUNIZACIONES																											
HCL		Emb	Eje	BCG	HVS	PV	APO	PENTAVALENTE	NEUMOCOCCO	ROTAVIRUS	INFLUENZA	SPR	AMA	OPT	APO	OTROS															
CUDI				RN	RN	1°	2°	1°	1°	2°	3°	1°	2°	1°	2°	1° Ref	2° Ref	1° Ref	2° Ref												
COORDINADOR																															
NOMBRE Y APELLIDOS	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO																														
	RECEN NACIDO				MENOR DE 01 AÑO								01 AÑO				02 AÑOS														
FNAC	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	1°	2°	3°	4°						
MADRE	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO																														
PADRE	03 AÑOS				04 AÑOS				05 AÑOS				MENOR DE 01 AÑO				01 AÑO				02 AÑOS				03 AÑOS						
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°				
DIRECCION Y REFERENCIA	SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES																														
	GOTAS				MICRONUTRIENTES																ATENCION POR MORBILIDAD IRA, EDA, ANEMIA, PARASITOS, EMERGENCIA Y OTROS										
TIPO DE RIESGO	DESCARTE DE ENFERMEDADES PREVALENTES																														
	Tuberculosis				ANEMIA								Parasitos								ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES Y DE SEGUIMIENTO										
PROGRAMA SOCIAL	TSH	FC	FQ	HSR	Detección de hemoglobina								Examen Sero de Hechas																		
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°																	

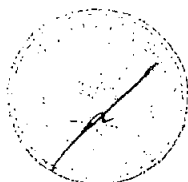
ANEXO N°5

EVALUACIÓN DEL EXAMEN FÍSICO

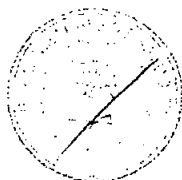
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN - OBSERVACIÓN
GENERAL	- Observar la relación de vínculo entre la madre, padre o cuidador con la niña o niño. - Observar el estado general de la niña o niño (estado de alerta, higiene y actividad de la niña o niño). - Realizar control de funciones vitales: Temperatura, frecuencia respiratoria, pulso y presión arterial.
PIEL, UÑAS, PÁPIRAS LABIALES Y UÑAS	- Observar en la piel el color, turgencia (elasticidad), hidratación, temperatura (cianosis, ictericia, palidez), valorar y describir la presencia de lesiones o anomalías como: eritema, pápula, macula, vesícula, ampolla, edema, escoriación y eccema (descartar dermatitis atópica); - Considerar la medición del diámetro de un hemangioma, manchas y lunares (coloración y engrosamiento), presencia de edema, manchas, lunares. - La coloración verdosa en zona sacro coccígea, son llamadas manchas mongólicas, son normales y desaparecen aproximadamente entre los dos años de edad. - Observar irritación o erupción de la piel por contacto prolongado con pañal mojado (Dermatitis perineal, perianal o en los pliegues de las ingles). Cuando hay presencia de hongos en la piel se observará lesiones eritematosas con bordes precisos (Dermatomycosis perineal). Derivar al pediatra. - Verificar en el cabello la textura (quebradizo) y coloración, tipo de implantación, cantidad. - Las uñas deben ser lisas y redondas, observar: el color, fragilidad (quebradizas), forma, limpieza y la presencia de uñeros. Realizar prueba del llenado capilar. - Observar signos sospechosos de violencia (moretones, quemaduras y otros). - Valorar el estado de higiene.
CEFEZA	- Palpar las suturas y fontanelas: si las fontanelas están prematuramente cerradas pensar en microcefalia, craneosinostosis, hipertiroidismo y derivar al especialista. - Verificar si las fontanelas están abombadas para identificar hipertensión endocraneana o meningitis. Si la fontanela está más amplia de lo normal puede deberse a hidrocefalia, hipotiroidismo, prematuridad, malnutrición. - Si encuentran las suturas cabalgadas, observar y realizar seguimiento con el control del P. Cefálico y compararlas con el padrón de referencia.
CARA	FACIE: - Observar la forma, simetría de movimientos (descartar parálisis facial), edema. OREJA: - Observar anomalías externas en pabellón auricular o ausencia de las mismas, implantación baja de las orejas, secreciones, higiene. Si hay otoscopio evaluar el tímpano: color, brillo, dolor o presencia de secreciones.



EVALUACIÓN - OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN - OBSERVACIÓN
CARA	OJOS: Inspeccionar la zona ocular externo (Anexo N° 6) - Párpados: observar presencia del párpado caído que tapa el eje visual (ptosis palpebral), edema, inflamación; si las pestañas se encuentran invertidas, rozando la conjuntiva (entropión), o evertido, dejando a la conjuntiva expuesta (ectropión). - La presencia de un repliegue del párpado, del superior al inferior (epicantos). - Conjuntivas y escleróticas: color (rojo, palidez, ictericia, esclera azulada), secreción. - Iris: cambios de color - Pupilas: presencia de reflejo pupilar; observar forma, color. La pupila blanca (leucocoria) puede ser catarata congénita o retinoblastoma, entre otras causas. - Reflejo rojo binocular debe estar presente. - Globos oculares: observar si estos son pequeños (microftalmos o nanoftalmos) o más grandes de lo considerado normal (glaucoma congénito). - Evaluar el movimiento de seguimiento de ambos ojos aplicando el Test de Hirschberg y de cubrir/descubrir. A partir de los 6 meses de edad, ver la posición, si están desviados hacia adentro, fuera, arriba o abajo (descartar estrabismo). El especialista realizará otras pruebas específicas como las opacidades en la transparencia de los medios oculares (Reflejo Luminoso Corneal o Test de Bruckner). - Evaluación de fijación monocular: aplicación del test cubrir/descubrir (cover/uncover). - Realizar la agudeza visual a partir de los tres años de edad. NARIZ - Observar si las fosas nasales están permeables: si respira bien por la nariz con la boca cerrada. Evaluar deformidades o desviación del tabique, presencia de congestión nasal y secreción sanguinolenta. Referir al especialista. BOCA - Descartar presencia de frenillo lingual corto, labio y/o paladar fisurado, maloclusiones. Referir al especialista. - Levantar el labio superior para detectar precozmente cambios de color o cavidades en los incisivos superiores y verificar higiene bucal. - A los 3 años, contar 20 dientes primarios. - Dar pautas de higiene bucal y cepillado con pasta fluorada (Anexo 11). - Referir al odontólogo para procedimientos preventivos y recuperativos (de ser necesario).
CUELLO	- Explorar simetría, flexibilidad, presencia de dolor, tumoraciones, aumento de volumen de los ganglios linfáticos cervicales o mandibulares y barbilla, de cada lado de la parte frontal o en ambos lados del cuello y por debajo de cada lado de la parte posterior. - Palpar detrás de los oídos y sobre la parte posterior de la cabeza. - De ser posible, evaluar la glándula tiroidea, buscando bocio congénito, nódulos o tumoraciones.



EXAMENES	EVALUACIÓN - OBSERVACIÓN
TÓRAX	- Observar la expansibilidad torácica, la frecuencia respiratoria al minuto, las características de los movimientos respiratorios, buscar de tiraje intercostal. - Inspeccionar el agrandamiento de la glándula mamaria o presencia de secreción láctea (normal en recién nacidos). - Auscultar ruidos normales y anormales cardiacos (soplos) y/o respiratorios (sibilantes, roncos, estertores). - Observar asimetrías, deformaciones (tórax en quilla, <i>pectum excavatum</i>), - En casos de cardiopatía, observar la presencia de cianosis distal, perioral, taquicardia, lactancia materna entrecortada por cansancio durante la succión y diaforesis. - De ser patológica derivar al especialista.
ABDOMEN	- Observar en el abdomen forma, motilidad de la pared abdominal (distendido o excavado), palpar la protuberancia umbilical: el tamaño y la retractilidad, signos inflamatorios (descartar hernia umbilical), en el caso de granuloma umbilical si existe secreción serohemática. - Inspeccionar si hay crecimiento del hígado por debajo del reborde costal (que es normal durante el primer mes), bazo y la presencia de masas o hernias - Auscultar los ruidos hidroaéreos, si se encuentran ausentes o aumentados. - Palpar hernia inguinal: la protrusión en la zona inguinal o inguino escrotal, se presenta durante el llanto o al pujo y disminuye al reposo. - Referir al especialista.
COLUMNA VERTEBRAL	- Observar asimetrías, rigidez y postura cuando la niña o niño está sentado, de pie y acostado, verificando si hay desviaciones de la curvatura normal de la columna. Deben encontrarse alineadas desde las vértebras cervicales hasta la línea interglútea. - En el recién nacido evaluar presencia de un bulto graso, mancha rojiza, zona de pelos largos anormales u orificio cutáneo en cualquier zona desde el cuello a la región sacrocoxígea (descartar espina bífida o espina bífida oculta). Derivar al especialista. - Fóvea pilodinal es la presencia de una depresión o fosa en la región sacra. Debe mantenerse en buen estado de higiene a fin de evitar infecciones. - La lordosis, escoliosis y xifosis, se evalúan en especial en niños mayores de 2 años.
EXTREMIDADES	- Realizar en todas las consultas las maniobras de descarte de Displasia de cadera: valorar el signo de Barlow y de Ortolani, en especial en los RN. (Anexo N° 8) - En mayores de 3 meses de edad, observar otros hallazgos: asimetría de pliegues de uno de los miembros inferiores, sea en la cara interna de muslos o zona glútea; limitación en la abducción en uno de los miembros, en el lado afectado. - En niños de 18 meses, observar piernas arqueadas y dificultad en la marcha. - A partir de los 2 años, además, examinar el proceso de marcha y el arco plantar para presumir pie plano. - En todos estos casos derivar al médico o especialista en Ortopedia. - Recomendar a la madre, padre o cuidador no usar andador y forzar a andar a su niña o niño. - Según las condiciones de salubridad, recomendar no usar zapatos o zapatillas antes de la marcha estable.



	EVALUACIÓN – OBSERVACIÓN
EXAMEN UROLOGICO	- Observar el tamaño y forma de los genitales externos, higiene, presencia de inflamación, dolor o secreciones, búsqueda de algún signo sospechoso de violencia - En niñas: observar labios mayores menores, clitoris, himen. Detectar adherencias anormales de labios (labios menores unidos y no se observa himen). - En niños: determinar el tamaño, ubicación, palpación de los testículos y volumen. - No hacer ningún tipo de ejercicios porque la mala manipulación produce inflamación, dolor o infecciones urinarias. - Criptorquidia, si ambos o uno de los testículos han descendido o están ausentes. - Hidrocele, aumento de volumen de la zona escrotal de consistencia líquida. <u>No derivar antes del año</u>, pero descartar en caso que sea tenso y grande (presencia de una masa que puede ser hernia escrotal). - Fimosis: observar el pene en la zona del prepucio, la estrechez del orificio del prepucio impide la salida del glande o al retraerlo hay adherencias (balano prepucial). Referir <u>a partir de los dos años edad</u> (Se le denomina fimosis fisiológica). - Epispadias: es cuando hay meato uretral en la zona dorsal del pene. - Hipospadia: hay meato uretral debajo de la punta del pene. - En todos estos casos referir al médico o al especialista en cirugía pediátrica.
ANO	- En recién nacidos verificar características y permeabilidad. - En los niños de mayores de 2 meses de edad, en posición de cúbito dorsal, observar fisuras, erupciones, cicatrices, fístulas perianales o malformaciones ano-rectales. - Valorar la eliminación: preguntar al padre/cuidador por las características de las deposiciones, si estas son duras, secas y están acompañadas de esfuerzo (estreñimiento) - Estar atentos ante un algún signo de violencia o maltrato. - En todos estos casos referir al médico o al especialista en cirugía pediátrica.
EXAMEN NEUROLOGICO	- Valorar los antecedentes de riesgo durante la etapa pre-natales, natales y post-natales del niño. - El ambiente al evaluar debe ser cálido y con menos estímulos distractivos posibles. - Preguntar por el patrón de sueño: se despierta fácilmente con cualquier ruido o duerme por periodos cortos. - Tener en cuenta el llanto y la irritabilidad continua y persistente. - Observar al niño en su relación con el entorno, si es irritable o tiene llanto continuo, la postura del cuerpo, tener en cuenta asimetrías faciales o del cuerpo. - Valorar tono muscular, que es la capacidad de tensión de rigidez o flacidez que tienen los músculos al realizar un movimiento (hipertonía o hipotonía) y la fuerza, que es la capacidad de resistencia que ofrezca cada área evaluada (miembros superiores, tórax, columna pelvis y miembros inferiores), de acuerdo a su edad, así como la postura, que es la posición que presenta el cuerpo de la niña o niño. Cuando se le coloca en una superficie debe ser simétrica y armoniosa. - Evaluar los pares craneales (Anexo N°9) y los reflejos primarios básicos (Anexo N°10). - Tener presente que en el Recién Nacido encontraremos resistencia y que tanto miembros superiores como inferiores están flexionados simétricamente; a medida que pasan los meses presenta una gran flexibilidad. - El desarrollo psicomotor es céfalo-caudal, próximo distal y de simple a lo complejo (tendencias direccionales).



ANEXO N° 6
PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE ALTERACIONES VISUALES

INSPECCIÓN OCULAR	El evaluador, a una distancia de 30 centímetros, dirige la fuente de luz hacia los ojos de la niña y el niño, valora las características de los párpados, pestañas, conjuntiva, transparencia de la córnea, presencia y forma de la pupila, así como la presencia de lagrimeo permanente o secreciones.	El resultado anormal está dado por la presencia de cualquier alteración anatómica o morfológica del ojo y/o sus anexos.	RN a 5 años	Anormalidad estructural
REFLEJO DE PARPADEO	Se explora aplicando una luz repentinamente sobre los ojos, provocando así el parpadeo de defensa. Aparece desde el nacimiento.	La ausencia de este reflejo nos indicaría desde edad temprana una deficiencia visual severa. (Gessell, Fleming, Koupemik).	RN a 5 años	Respuesta a la luz pobre o ausente.
REFLEJO PUPILAR	Consiste en la contracción de la pupila por acción de la luz sobre la retina y se explora con una linterna u oftalmoscopio directo. Aparece en el nacimiento y permanece siempre.	El resultado anormal está dado por la respuesta a la luz pobre o asimétrica.	RN a 5 años	Respuesta a la luz pobre o asimétrica.
REFLEJO ROJO BINOCULAR Test de Bruckner o Reflejo rojo retiniano	A una distancia de 1 metro se dirige la luz del oftalmoscopio directo hacia ambos ojos del examinado y se observa, a través del mismo, buscando en el área de las pupilas presencia de un reflejo naranja-rojizo, bilateral y simétrico.	El resultado anormal está dado por ausencia, disminución o asimetría del reflejo. Sospechar de Catarata Congénita o Retinoblastoma.	RN a 5 años.	Ausente, opaco, asimétrico, presencia de un reflejo blanco o manchas negras en el reflejo rojo.
SEGUIMIENTO AMBOS OJOS	A una distancia de 50 cm por delante de los ojos del/la niño(a) se busca que mire el objeto y lo siga con la mirada a medida que el examinador desplaza el objeto de un lado a otro. El ambiente debe estar bien iluminado, con los dos ojos descubiertos y en simultáneo.	Se considera anormal cuando a los 3 meses no sigue el objeto de colores llamativos durante el examen.	3 meses	Incapacidad de fijación y seguimiento.
FIJACIÓN MONOCULAR	Para evaluar el OD se ocluye el OI, se coloca a una distancia de 50 cm por delante de los ojos de la niña (o), buscando que mire el objeto con el ojo descubierto. Luego el evaluador verifica que siga con la mirada mientras desplaza el objeto de un lado a otro. Seguidamente se procede a evaluar el OI.	Anormal, cuando a los 6m de edad o más hay ausencia de fijación. También indicativo de un hallazgo negativo el hecho en que la/el niña(o) lllore o rechace la oclusión de uno de los ojos (del ojo que ve mejor). Sospecha de Ambliopía Profunda.	6, 12 y 36 meses	Incapacidad de fijación y seguimiento



ANEXO N° 7

DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE LA AUDICIÓN

DEFICIENCIA AUDITIVA CONGÉNITA	✓ El recién nacido no se asusta con un fuerte ruido ✓ No reacciona ante sonidos inesperados ✓ A los cuatro meses de edad: no gira su cabeza a la fuente de un sonido o a la dirección al sonido de la voz Ante la sospecha derivar al especialista.
PÉRDIDA AUDITIVA	✓ A partir de los 6 meses a más edad: no dice sílabas ni palabra. ✓ Al año de edad: ve a la madre pero no responde a su llamada. ✓ Dificultad en escuchar y entender las conversaciones. ✓ No reaccionan al sonido de las campanas de la puerta o el timbre del teléfono. ✓ Dificultad para comprender las órdenes.
DEFICIENCIA AUDITIVA LEVE	✓ Parece oír algunos sonidos pero no todos los sonidos. ✓ Dificultad para comprender un discurso susurrante.
DEFICIENCIA AUDITIVA MODERADA	✓ Dificultad en las siguientes conversaciones por teléfono. ✓ escuchar música o la televisión a un volumen superior a otras personas. ✓ Pobre desarrollo del lenguaje, a menudo preguntan por el altavoz para repetir y tienen más dificultad para ser comprendidos. ✓ Presentan retraso en aprender a hablar, hablan claro, en voz alta o invitan al orador a repetir los mismos y subir el volumen del televisor o radio. ✓ En edades preescolares se presentan trastornos del aprendizaje de distintos grados.
DEFICIENCIA AUDITIVA SEVERA	✓ No pueden oír palabras gritos y necesitan el lenguaje de señas para la comunicación. ✓ En los preescolares necesitan el lenguaje de señas para la comunicación.

Recomendaciones:

- Todas las niñas y niños con indicadores de riesgo deben ser referidos al nivel de atención correspondiente para ser evaluados por el médico especialista, a fin de realizar otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos de tallo en el periodo neonatal o en los primeros meses de vida.
- Considerar indicadores de riesgo auditivo neonatal: historia familiar de hipoacusia neurosensorial congénita instaurada en la primera infancia; infecciones intrauterinas (entre ellas el TORCH), malformaciones craneofaciales, peso al nacimiento inferior de 1.500 g., hiperbilirrubinemia grave, uso de fármacos ototóxicos, meningitis bacteriana, hipoxia-isquemia perinatal, ventilación mecánica durante más de 5 días o estancia mayor de 48 horas en Unidad de Cuidados Intensivos neonatales.
- En las niñas y niños mayores de 28 días, considerar Indicadores de Riesgo: sospecha de hipoacusia o de retraso del lenguaje, meningitis bacteriana u otras infecciones que puedan cursar con hipoacusia. Los antecedentes de traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura craneal, uso de fármacos ototóxico y otitis media secretora recurrente o persistente, dolor, zumbido en el oído.



REFLEJO LUMINOSO CORNEAL Test de Hirschberg	Se realiza mediante una fuente de luz situada a 30 cm del puente nasal observando si hay reflejo luminoso en la pupila de ambos ojos, de manera simétrica.	Desalineamientos.	6 meses a 5 años	Asimétrico o desplazado. Signos de Estrabismo.
COVER TEST cubrir/descubrir	Se procederá a cubrir uno de los ojos, con un cono de cartulina blanca, al ser éste destapado luego de tres segundos, se observará un movimiento inmediato de fijación, esto significará que hay estrabismo. En caso que sea normal el ojo no se moverá.	Detectar tempranamente desalineamientos oculares como estrabismos o atropías.	6 meses a 5 años	Movimiento de uno o ambos ojos no tapados.
AGUDEZA VISUAL	Se utiliza la cartilla de Snellen de la "E" direccional, adaptada para 3 metros, de preferencia (puede utilizarse también la de 6 metros), en un lugar bien iluminado. Enseñarle al niño a contestar "para qué lado están las patitas del dibujo (E)". Utilizar un oclisor para cubrir el ojo izquierdo e iniciar la evaluación del ojo derecho. Solicitar al menor que señale con su mano la direccionalidad de las barras de la letra "E" contenidas en cada fila, de izquierda a derecha. Empezar por la letra "E" más grande (superior), hasta que el niño manifieste que no ve la letra señalada o se equivoque en su direccionalidad. Anotar la agudeza visual que corresponde a la fracción ubicada al inicio de la última línea que pudo leer completa o la última línea en la que leyó más de la mitad de las letras u optotipos. Occluir el ojo derecho y repetir secuencia con ojo izquierdo. En los niños que ya usan lentes evaluarlos con lentes puestos.	Es normal que la/el niña(o) a esta edad tenga una agudeza visual de 20/20 a 20/40. La diferencia de agudeza visual entre ambos ojos no debe superar 1 línea.	3 a 5 años	Agudeza visual $\leq$ 20/50 en cualquiera de los dos ojos o que la agudeza visual de un ojo con relación al otro difiera en dos líneas o más de la Cartilla de Snellen.

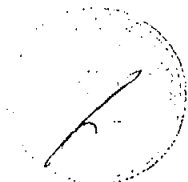
RECOMENDACIONES

- Evaluación en la niña y niño prematuro y de bajo peso:
La evaluación se realizará de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica de Retinopatía de la Prematuridad: RM N° 539-2006/MINSA y documentos técnicos complementarios vigentes.
- Evaluación en el niño a término y peso adecuado para la edad:
La trascendencia de la evaluación de la visión radica en que la mayor parte del proceso de aprendizaje se da a través de la visión; por lo tanto es de suma importancia la detección precoz e intervención oportuna de déficit visual, a fin de contribuir en el desarrollo óptimo de la niña o niño.



CARTILLASNELLEN

E	1	20/200
F P	2	20/100
T O Z	3	20/70
L P E D	4	20/50
P E C F D	5	20/40
E D F C Z P	6	20/30
F E L O P Z D	7	20/25
D E F P O T E C	8	20/20
L E F O D F C T	9	
F D P L T C E O	10	
P E E L C F T D	11	



ANEXO N°8

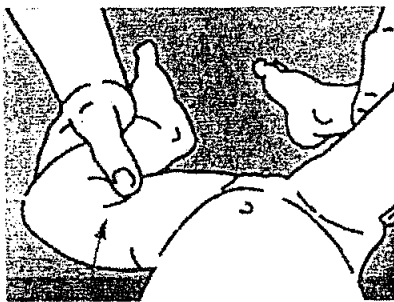
EVALUACIÓN ORTOPÉDICA

1. DISPLASIA CONGÉNITA DE CADERA

Es una alteración del desarrollo de la cadera y puede tener distintos grados, desde una displasia del acetábulo hasta una luxación de la cadera. Entre los factores de riesgo más importantes se encuentran los antecedentes familiares en primer grado de displasia de caderas, el sexo femenino, la presentación podálica. También existe una asociación con ser primogénito, embarazos múltiples y tener otros problemas congénitos (pie talo, tortícolis, metatarso varo) o antecedentes de la gestación (oligohidroamnios).

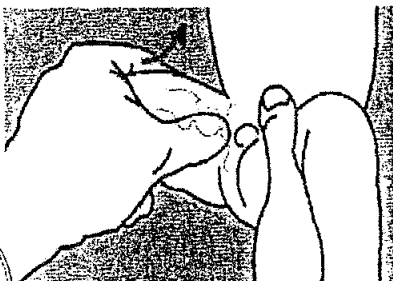
En el examen físico del lactante deben descartarse los siguientes signos:

- **Limitación de la abducción:** al abrir la pierna como un libro no sobrepasa los 60°.
- **Signo de Ortolani positivo:** con la niña o niño acostado de espaldas y con las caderas flexionadas en ángulo recto, se apoya el pulgar en la cara interna del muslo y el dedo medio a nivel del trocánter mayor. Al abducir (alejar de la línea media) se siente un "clic" de entrada de la cabeza del fémur en el acetábulo.

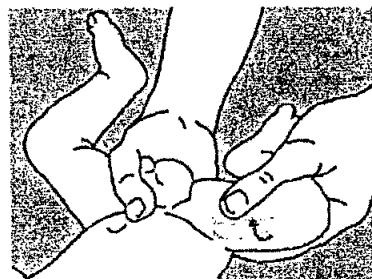


Se sujetan las dos piernas por debajo, con el dedo índice verificar si hay o no limitación de la apertura de ambas caderas.

- **Signo de Barlow positivo:** con la niña o niño acostado de espaldas y con las caderas flexionadas en ángulo recto, se apoya el pulgar en la cara interna del muslo y el dedo medio a nivel del trocánter mayor. Al aducir (aproximar a línea media) se siente un "clic" de entrada de la cabeza del fémur en el acetábulo.



El evaluador sujeta con una mano una cadera, mientras que con la otra intenta la maniobra



Se lleva la primera pierna hacia arriba y hacia afuera esperando el resalto o el clic.

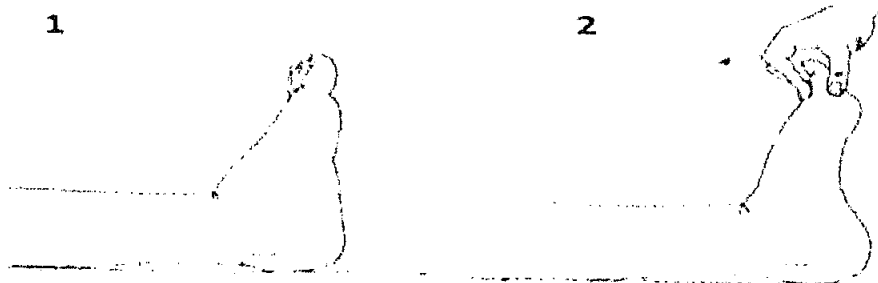


Evaluación que debe realizarse principalmente a partir de los 6 meses de edad. Se observa tredelemburg positivo, acortamiento, rotación externa de la pierna y posición de puntillas; disimetría y asimetría de pliegues en la unilateral y aumento de espacio perineal con hiperlordosis en la bilateral. Siempre está limitada la abducción. Al extender la cadera se puede palpar un bulto en la región inguinal que corresponde a la cadera luxada en anterosuperior.

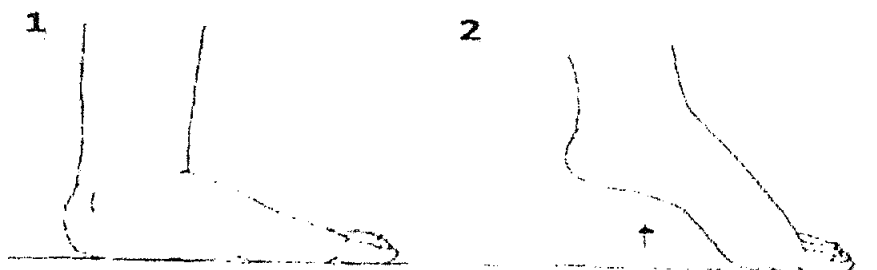
2. PIE PLANO

Alteración caracterizada por un aumento del área de contacto plantar con arco longitudinal interno disminuido o ausente. Después de los 3 años es posible empezar a descartar el pie plano, ya que en los menores existe una almohadilla de grasa palmar que aumenta el área del pie con el suelo. En caso de existir pie plano en las niñas o niños mayores de 3 años es necesario identificar si es flexible o rígido. Para ello existen dos maniobras recomendadas:

- a) Acostar a la niña o niño en la camilla con los talones en ángulo recto y luego presionar suavemente el primer dedo del pie hacia el empeine.



- b) Con la niña o niño parado y apoyado en una muralla, solicitar que levante el talón y se mantenga parado apoyándose en los metatarsos. Esto también se observa en:



- *Pie plano rígido*: si cuando se presiona el primer dedo del pie o cuando la niña o niño levanta los talones y se produce una elevación del arco interno.

- *Pie plano flexible es fisiológico*: si no se produce la elevación del arco interno se observa en la marcha y apoyo del pie. La gran mayoría tiene una etiología desconocida. Se piensa que se produce por hiperlaxitud ligamentaria y mayor presencia de tejido graso en el pie. No requiere tratamiento. Se debe derivar al traumatólogo infantil cuando está asociado a dolor

3. MARCHA

Es el desplazamiento corporal que la niña o niño realiza a través de la parada. Se evalúa a partir de los 15 meses. Para hacer un buen examen de la marcha, hay que dejar con pocas prendas a la niña o niño, mirarlo por adelante, atrás y delado, primero en reposo y luego caminando. En reposo, solo con ropa interior, y de pie, observando de frente y de espalda la simetría del



cuerpo, articulaciones, huesos (pelvis, escápula) y de los pliegues. De lado, deben evaluarse las curvas de la columna, buscando una patología frecuente como dorso curso o hiperlordosis lumbar. Luego pedir la niña o niño que camine, idealmente varios metros, para observar simetría o claudicación y estabilidad de la marcha.

a) Marcha normal

Es aquella que permite realizar un menor gasto energético al organismo y provee de libertad de movimiento para la realización de actividades, como caminar, correr y hacer deporte. Para que la marcha normal pueda suceder, se requiere integridad del sistema nervioso, muscular y osteoarticular. Habitualmente la marcha se inicia entre los 10 y 15 meses, si la marcha no ha iniciado a los 18 meses debe ser estudiada. Al comienzo la marcha es insegura e inestable, el niño o la niña camina con las piernas arqueadas fisiológicamente (genu varo) y con los codos flectados. Hacia los 3 años la marcha es más segura, en este momento las piernas se arquean en genu valgo (rodillas juntas, pies separados y rotados levemente hacia adentro, simétrico). Muchas veces a esta edad los preescolares miran al suelo para tener más estabilidad y esto es normal.

b) Marcha Patológica

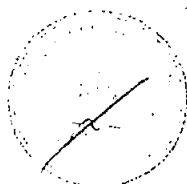
Evaluar la presencia de marcha en punta de pie (marcha equina) o en talones (posición talo), ver si hay claudicación de la marcha (cojera). La claudicación es siempre un síntoma de alarma pues puede ser síntoma de patología traumatológica de alta complejidad, por ejemplo, infección osteoarticular, traumatismos, neoplasias, enfermedades neuromusculares o autoinmunes, enfermedad de Perthes. La marcha patológica puede ser causada por diferentes causas: dolor, deformidades estructurales (huesos y articulaciones), desórdenes neuromusculares y debilidad muscular aislada.



ANEXO N°9

EVALUACIÓN DE LOS PARES CRANEALES

PAR CRANEAL	INDICADORES DE EVALUACIÓN
OLFATORIO (I)	Se valora utilizando sustancias de olores conocidos (clavo de olor, café, perfume, etc); evaluar cada fosa nasal por separado (solicitar que el niño o niña mantenga la boca y ojos cerrados). En el recién nacido se explora poco por lo difícil de obtener una respuesta.
ÓPTICO (II)	La visión se valora con la respuesta de parpadeo a la luz intensa. Se puede buscar el seguimiento ocular cuando se pasa por el frente un objeto luminoso y de forma circular. La visión se valora con diferentes pruebas de evaluación: • Reflejo del parpadeo como respuesta a la luz intensa. La ausencia de este reflejo, nos indicaría desde edad temprana una deficiencia visual severa. (Gessell, Fleming, Koupernik). • Presencia del Reflejo rojo binocular: debe estar presente. Si está ausente, blanco, pálido, opacidad o asimétrico hay que realizar referenciainmediata.Normalidad estructural a la inspección externa de ambos ojos. • Fijación y seguimiento ocular cuando se pasa por el frente un objeto luminoso y de forma circular desde los 3 a 6 meses de edad. • Fijación y seguimiento en cada ojo (monocular) de 6 a 12 meses de edad y hasta que el niño tenga la edad suficiente para cooperar con la toma de agudeza visual verbalmente. • De 3 a 5 años de edad: se toma la agudeza visual (monocular). Referir con 20/50 o peor en cualquiera de los dos ojos o existencia de 2 líneas de diferencia entre ambos ojos (GPC de errores refractivos MINSA).
ÓCULOMOTORES (III-IV-VI)	Valorar pupilas y observar presencia de anisocoría, miosis o midriasis. Los movimientos oculares se valoran con rotación de la cabeza y búsqueda de ojos de muñeca, teniendo en cuenta que la mirada lateral está presente desde el nacimiento y la mirada vertical y movimientos conjugados se presentan a partir del tercer mes.
TRIGÉMINO (V)	Se valora buscando la succión, aunque también intervienen otros pares. Se busca la sensibilidad de la cara con un estímulo táctil, observando la retirada del estímulo. Al examinar el reflejo corneano se observa la simetría en la respuesta.
FACIAL (VII)	Observe simetría de la cara, durante movimientos espontáneos y provocados (llanto).
AUDITIVO (VIII)	Explore haciendo un ruido que lleve a obtener una respuesta de parpadeo o un reflejo de Moro. La rama vestibular se explora tomando al niño por el tronco y en posición vertical, se le hace girar hacia un lado y luego hacia el otro y se observa la respuesta de desviación ocular al lado opuesto que gira.
GLOsofaríngeo Y NEUMOGÁSTRICO (IX-X)	Se valora junto con otros pares: movimientos de succión, deglución, reflejo nauseoso e intensidad del llanto.
ESPINAL (XI)	Se valora observando movimientos de la cabeza, principalmente los movimientos laterales, con visualización y palpación del esternocleidomastoideo.
HIPOGLOSO (XII)	Observe movimientos de la lengua y simetría



ANEXO N°10

EVALUACIÓN DE LOS REFLEJOS PRIMARIOS EN EL RECIÉN NACIDO

TONICO ASIMÉTRICO DEL CUELLO (Posición del esgrimista)	La persistencia sugiere una alteración neurológica	Antes de los dos meses	Mantener en posición de cúbito supino, girar la cabeza del bebe hacia un lado colocando la mandíbula sobre su hombro. El brazo y la pierna del lado hacia el que sea girado presentan extensión mientras que los miembros del lado contralateral presentan flexión. Se repite la maniobra con giro de la cabeza hacia el otro lado
DE SUCCIÓN	Es importante para la adecuada alimentación del bebe.	Hasta la madurez	Se introduce el dedo meñique entre los labios de la niña y el niño, este inicia el chupeteo con fuerza, succionando un mínimo de 5 a 6 veces con energía de forma continua y sin fatiga.
DE BÚSQUEDA	Valoración de la simetría, fuerza y tono de los músculos de la cara	De 3 a 9 meses	Se toca o acaricia la comisura de los labios provocando el giro de la cabeza, buscando el estímulo (puede ser durante la lactancia la madre le ofrece el pezón).
MORO	Da a conocer que la niña o niño responde a los sonidos y tendrá que ver en el futuro con el equilibrio.	4 meses	Se puede provocar, al hacer un ruido con las manos golpeando la mesa de examen clínico, hacia los lados del bebe. El reaccionará con un sobresalto como si se "asustara". Veremos una reacción de todo su cuerpo, extendiendo brazos y piernas.
PRESIÓN PALMAR	Este reflejo representa la futura prensión de la mano en el niño.	4 meses	Colocar el dedo índice en la palma de la mano de la niña y el niño y hacer una ligera presión. La respuesta es la flexión de los dedos del niño, como si agarrara su dedo.
PRESIÓN PLANTAR	Este reflejo representa la futura marcha adecuada en el bebe.	9 meses	Presionar con el dedo la zona de la planta del pie (inmediatamente por debajo de los dedos del pie del bebe). La respuesta es la flexión de los dedos del pie del bebe.
PARADA ESTÁTICA O DE APOYO	Su ausencia sugiere hipotonía o flacidez. La extensión y abducción fijas de los miembros inferiores (movimientos en tijeras) sugiere espasticidad secundaria.	2 a 6 meses	Se sostiene al bebe sujetándolo por el tronco y después se le desciende hasta que los pies estén en contacto con una superficie plana. Las caderas, rodillas y tobillos presentan extensión del bebe intenta mantenerse de pie soportando parcialmente su peso corporal (20 a 30 seg.) y después deja de hacerlo con los pies.
DE MARCHA	Su ausencia sugiere hipotonía o flacidez	2 a 3 meses	Se sostiene al bebe sujetándolo por el tronco y después se le desciende hasta que los pies estén en contacto con una superficie plana. Y se le provoca ir hacia adelante observando movimientos coordinados como la marcha.
DE GALANT	Permite el cambio de los movimientos de todo el cuerpo a los movimientos de un lado del cuerpo.	A los 9 meses logra la homolateralidad	Se coloca al bebe de cúbito ventral sobre sus manos, se roza con el dedo los dos lados de la columna (desde las vértebras cervicales hasta la coxígea) Primero hacia un lado y luego al otro. La respuesta es la curvación de la columna hacia el lado estimulado.

